सत्र सञ्चालन: तपाईं एक्लो हुनुहुन्न

मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार (PFA) को तालिम लिएका, सुपरिवेक्षक भएका र प्रेषण (रेफरल) को बाटो थाहा भएका व्यक्तिहरूका लागि ।



तत्काल खतरा छ? सत्र रोक्नुहोस्, त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् र अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस्; अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन । पूरा प्रक्रिया र सम्पर्क: पृष्ठ २ ।



पोस्टर A3



पर्चा, तीन पट्ट

तपाईंका सामग्रीहरू

पोस्टर · सबैको साझा ध्यान

समूहका लागि: छलफल सुरु गर्न, मानिसहरूले देखेका कुरा सोध्न र मुख्य सन्देशमा फर्कन प्रयोग गर्नुहोस् । सबैले देख्न सक्ने बनाउनुहोस्; हरेक लाइन ठूलो स्वरमा नपढ्नुहोस् ।

पर्चा · घर लैजाने विस्तृत जानकारी

कुनै प्रश्न आएमा वा नजिकबाट हेर्न, र आफूसँग राख्न वा अरूलाई दिन । सम्बन्धित भाग मात्र खोल्नुहोस् र सँगै पढ्ने प्रस्ताव गर्नुहोस् ।

एउटा वा दुवै सामग्री, जुनसुकै क्रममा प्रयोग गर्नुहोस् । दुवै सामग्री सक्नेमा होइन, मानिसलाई के चाहिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुहोस् ।

मानिसहरू आउनुअघि

- ☐ सुरक्षित, शान्त र सबैले पुग्न सक्ने ठाउँ छान्नुहोस्, र समूहका अगुवा वा आयोजकसँग अनुमति लिनुहोस् । सबैले देख्ने ठाउँमा पोस्टर टाँस्नुहोस्; पर्याप्त पर्चा ल्याउनुहोस् ।
- ☐ पृष्ठ २ मा सहयोग सम्पर्कहरू भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस्; जाँच नगरिएका सम्पर्क भएका पर्चा नबाँड्नुहोस् । निजी कुराकानीमा कसले सघाउन सक्छ, वा कसैलाई तत्काल सहयोग पाउन कसले मद्दत गर्न सक्छ भन्ने थाहा पाउनुहोस् ।
- ☐ भाषा र पहुँचको योजना बनाउनुहोस्: सरल शब्द, ठूला अक्षर, थप समय, वा आवश्यक र उपलब्ध भए साङ्केतिक भाषा दोभाषे । चित्र वा लेख बुझ्न वा हेर्न कठिन भए अरू विकल्प दिनुहोस् ।

सत्र करिब १५ मिनेट · योजना पूरा गर्न कसैलाई हतार नगराउनुहोस्, तत्काल सहयोगमा ढिलाइ नगर्नुहोस्

1 स्वागत र उद्देश्य बताउने · २ मिनेट · कुनै पनि सामग्री

गर्नुहोस् आफ्नो परिचय दिनुहोस् । सहभागिता स्वैच्छिक हो, मानिसहरू नबोली सुन्न सक्छन्, र कसैले पनि आफूलाई के भयो भनेर बताउनुपर्दैन भनी स्पष्ट पार्नुहोस् ।

भन्नुहोस् *"स्वागत छ । आज हामी पीडादायी अनुभवपछि मानिसहरूमा हुन सक्ने भावनाहरूबारे कुरा गर्नेछौं । मुख्य सन्देश हो: तपाईं एक्लो हुनुहुन्न । सहयोग गर्न सक्ने साना कुराहरू र सहयोग कहाँ माग्ने भन्नेबारे पनि छलफल गर्नेछौं ।"*

2 देखेका कुरा सोध्ने, अनि सुन्ने · ३ मिनेट · उपयोगी भए पोस्टर

गर्नुहोस् सन्देश बुझाउनुअघि करुणा र आशा सँगै बसेको दृश्यबारे बताउन मानिसहरूलाई आग्रह गर्नुहोस् । मौनता र फरक-फरक उत्तरलाई ठाउँ दिनुहोस् । पर्चा मात्र प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको आवरणबारे सोध्नुहोस् ।

सोध्नुहोस् *"यो चित्रमा तपाईं के देख्नुहुन्छ?"*

भन्नुहोस् *"मानिसहरूको प्रतिक्रिया फरक-फरक हुन सक्छ । तपाईंले आफ्नो कथा सुनाउनुपर्दैन ।"*

3 उपयोगी एउटा उपाय खोज्ने · ५ मिनेट · आवश्यकताअनुसार सामग्री बदल्दै

गर्नुहोस् अहिले केले सहयोग गरिरहेको छ भनेर सोध्नुहोस् । प्रयोग गरिरहेको सामग्रीमा छापिएका उपायहरूलाई संकेतका रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्; कसैलाई थप जानकारी चाहिएमा पर्चा खोल्नुहोस् । सबैलाई एउटै काम गर्न नलगाई यहाँ के सम्भव छ भनेर छलफल गर्नुहोस् । सास फेर्ने अभ्यास ऐच्छिक हो; कसैलाई झन् नराम्रो लागेमा रोक्नुहोस् ।

सोध्नुहोस् *"गाह्रो दिनमा तपाईं वा तपाईंको परिवारलाई केले सहयोग गर्छ? तपाईं प्रयास गर्न चाहने कुनै एउटा सानो कुरा छ?"*

4 सहयोग पाउने बाटो स्पष्ट पार्ने · २ मिनेट · सम्बन्धित सहयोग भाग

गर्नुहोस् कुनै पनि सामग्रीको सहयोग भाग प्रयोग गर्नुहोस् । स्थानीय रूपमा जाँच गरिएको सम्पर्क र सहयोगसम्म कसरी पुग्ने भनेर बताउनुहोस् । पहुँचबारे प्रश्न सोध्न आग्रह गर्नुहोस्, आफ्नो व्यक्तिगत पीडा सबैका अगाडि सुनाउन होइन । निजी कुराकानीको प्रस्ताव गर्नुहोस्; चिन्ताको कुरा आएमा पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

भन्नुहोस् *"धेरै नराम्रो नहोउन्जेल पर्खनुपर्दैन । सहयोगसम्म कसरी पुग्ने भनेर हामी निजी रूपमा कुरा गर्न सक्छौं ।"*

5 बुझाइ जाँच्ने र समापन · २ मिनेट · राख्नका लागि पर्चा दिनुहोस्

गर्नुहोस् पर्चा दिनुहोस्, यो कसरी खुल्छ देखाउनुहोस्, र सम्बन्धित भाग भेट्टाउन सहयोग गर्नुहोस् । परीक्षाजस्तो नभई नरम तरिकाले बुझाइ जाँच्नुहोस् । मानिसहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् र सत्रपछि तपाईंलाई कहाँ भेट्न सकिन्छ भनेर बताउनुहोस् ।

सोध्नुहोस् *"तपाईं वा घरका कसैलाई सहयोग चाहिएमा, सहयोग कहाँ खोज्नुहुन्छ भनेर मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ?"*

सुरक्षा, प्रेषण र कार्यकर्ताका सीमाहरू

कसैमा यी कुरा देखिए अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्:

संकेतहरू

- आत्महत्याको, वा आफूलाई वा अरूलाई हानि पुऱ्याउने कुरा गर्छ
- आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन, वा आफ्नो जिम्मामा रहेको बच्चाको हेरचाह गर्न सक्दैन
- धेरै अलमलमा परेको देखिन्छ, वा आफू कहाँ छ भन्ने थाहा पाउँदैन

के गर्ने

1. त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् ।
2. अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्: यस क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी वा आपतकालीन सेवा ।
3. आत्महत्याबारे सिधै सोध्नु ठीक हो । सोध्दैमा उहाँको मनमा त्यो विचार आउँदैन ।
4. स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस् । अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन ।

कोही विचलित भएमा

- शान्त रहनुहोस् र नजिकै बस्नुहोस् ।
- उहाँ चाहनुहुन्छ भने समूहबाट टाढा अलि शान्त ठाउँ दिनुहोस् ।
- बोल्न कर नगर्नुहोस् । अहिले उहाँलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्नुहोस् ।
- उहाँ चाहनुभएसम्म, वा उहाँले विश्वास गर्ने कोही साथमा नआएसम्म बस्नुहोस् ।

PFA: हेर्ने, सुन्ने र जोड्ने

हेर्ने: सुरक्षा, तत्काल आवश्यकता, अत्यन्त विचलित मानिसहरू
सुन्ने: आवश्यकता र चिन्ताबारे सोध्ने; शान्त हुन सहयोग गर्ने
जोड्ने: आधारभूत आवश्यकता, सेवा, जानकारी, आफन्त

यस्तो भएमा निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस् र थप सहयोगसँग जोड्नुहोस्

- भावनाहरू झन् गाह्रा हुन्छन्, सुधार हुँदैनन्, वा दैनिक जीवन धेरै कठिन बनाउँछन्
- आफ्नो वा आफ्ना बालबालिकाको हेरचाह गर्न सक्नुहुन्न
- शरीरको कुनै समस्याले चिन्तित बनाएको छ: दुखाइ, ज्वरो, चोटपटक, वा धेरै दिनसम्म खान वा सुत्न नसक्नु

उहाँको सहमतिमा: विकल्पहरू बताउनुहोस्, सकेमा साथै जानुहोस्, र आवश्यक कुरा मात्र अरूलाई बताउनुहोस् ।

✓ गर्नुहोस्

- ✓ सरल शब्द प्रयोग गर्नुहोस् र मौनताको सम्मान गर्नुहोस्
- ✓ सुरक्षाको सीमाभित्र मानिसका विश्वास र सामना गर्ने तरिकाको सम्मान गर्नुहोस्
- ✓ सबैलाई जवाफ दिन समय दिनुहोस्
- ✓ सोध्ने जोकोहीसँग पछि निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस्

✗ नगर्नुहोस्

- ✗ समूहका अगाडि कसैलाई उहाँलाई के भयो भनेर बताउन नलगाउनुहोस्
- ✗ मानिसलाई कस्तो महसुस गर्नुपर्छ, वा अब त सबै बिर्सिसक्नुपर्ने हो भनेर नभन्नुहोस्
- ✗ निदान नगर्नुहोस्, वा औषधिबारे सल्लाह नदिनुहोस्
- ✗ दिन नसक्ने सहयोगको वाचा नगर्नुहोस्

तपाईंको भूमिका



यो निर्देशिकाले सत्र सञ्चालनमा सहयोग गर्छ; यसले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचारको तालिमको ठाउँ लिँदैन । आफ्नो तालिम, सुपरिवेक्षक र थाहा भएका प्रेषणका बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।

आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोस्: विश्राम लिनुहोस्, आफ्ना सुपरिवेक्षक वा सहकर्मीसँग कुरा गर्नुहोस्, र चाहिएको बेला सहयोग माग्नुहोस् ।

यस क्षेत्रका सहयोग सम्पर्कहरू कुराकानी अघि भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस्

स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्था _____

तत्काल सहयोग _____

अन्य सहयोग _____



स्रोतहरू: WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); WHO, Doing What Matters in Times of Stress (2020); IASC, Guidelines on MHPSS in Emergency Settings (2007); WHO/UNHCR, mhGAP Humanitarian Intervention Guide (2015) । यो सामग्री यी प्रकाशनहरूमा आधारित छ; यसलाई WHO वा IASC ले तयार गरेका होइनन्, र तिनीहरू यसको विषयवस्तुका लागि जिम्मेवार छैनन् ।

यो सामग्री केका बारेमा हो

पोस्टर र पर्चामा दैनिक बोलचालका शब्द प्रयोग गरिएको छ, ताकि आफूले भोगेको कुरा ट्रमा (आघात) *"गनिन्छ"* कि गनिँदैन भनेर पहिले नै निर्णय नगरी मानिसहरूले यी सामग्री प्रयोग गर्न सकून् । यो पृष्ठले ती शब्दहरूको पछाडिको अर्थ र तपाईंको भूमिकाका सीमाहरू बताउँछ ।

शब्द कुञ्जी

पोस्टर वा पर्चामा	हाम्रो अर्थ	कुराकानीमा कसरी सम्हाल्ने
"धेरै मानिसलाई यस्तै महसुस हुन्छ"; "तपाईंलाई दुःखी, चिन्तित वा डराएको, रिसाएको, निद्रा नलागेको महसुस हुन सक्छ"	पीडादायी, सम्भवतः आघातपूर्ण अनुभवपछिका सामान्य तनाव प्रतिक्रियाहरू: अपेक्षित प्रतिक्रिया, मानसिक रोगका लक्षण होइनन्	*"सामान्य प्रतिक्रिया"* भन्नुहोस् । आफैंले *"लक्षण"*, *"ट्रमा"* वा *"रोग"* जस्ता शब्द नल्याउनुहोस् । सहभागीहरूले यी शब्द प्रयोग गरेमा नसच्याई र निदान नगरी स्वीकार गर्नुहोस्, र उहाँहरूको अर्थ के हो भनेर सोध्नुहोस् (तल हेर्नुहोस्)
"सहयोग गर्न सक्ने साना कुराहरू"	मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार र WHO को *Doing What Matters* बाट लिइएका आत्म-सहयोग र सामना गर्ने तरिका: साथ, आराम र आधारभूत आवश्यकता, बिस्तारै सास फेर्ने, सजिलै गर्न सकिने एउटा काम, दिनचर्या	उपचार वा निको पार्ने तरिकाका रूपमा होइन, विकल्पका रूपमा दिनुहोस्; कसैले सबै प्रयास गर्नुपर्दैन
"अवस्था झन् बिगार्न सक्ने सामना गर्ने तरिकाहरू"	हानिकारक सामना: रक्सी वा लागूपदार्थ प्रयोग, लामो समय एक्लै बस्ने, आक्रामकता, अत्यधिक काम	दोष नदिई वर्णन गर्नुहोस्; निजी कुराकानीको प्रस्ताव गर्नुहोस्
"समयमै सहयोग माग्नुहोस्"· "अहिले नै सहयोग लिनुहोस्"	समयमै सहयोग: लामो समय रहिरहने, झन् बढ्ने वा दैनिक जीवनमा असर गर्ने प्रतिक्रियाहरू । तत्काल सहयोग: आत्महत्या वा आत्म-हानिको जोखिम, अरूलाई खतरा, अचानक अलमल	यी दुईलाई छुट्टै राख्नुहोस् । सहयोग माग्न कसैले अवस्था झन् नराम्रो नहोउन्जेल पर्खनुपर्दैन

सामान्य प्रतिक्रियाहरू, र कहिले थप हेर्ने

पहिलो केही दिन र हप्ताहरू

पीडादायी वा आघात पुऱ्याउन सक्ने अनुभवपछि प्रतिक्रियाहरू हुनु अपेक्षित हो: डर, दुःख, रिस, राम्रो निद्रा नपर्नु, दुःखद सम्झनाहरू, झर्को लाग्नु । यी सामान्य प्रतिक्रिया हुन्, मानसिक रोग होइनन् । धेरै मानिसका लागि, विशेष गरी सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकता र साथ पाएपछि, यी बिस्तारै कम हुन थाल्छन् ।

घटनाको करिब एक महिनापछि

प्रतिक्रियाहरूमा कुनै सुधार नभएमा, झन् बढ्दै गएमा, वा दैनिक जीवन कठिन बनाएमा, मूल्याङ्कनका लागि त्यो व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् । कुनै अवस्था छ कि छैन भनेर तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्र मूल्याङ्कन गर्छन् ।

जुनसुकै बेला

खतरा छ भने अहिले नै सहयोग लिनुहोस् (पृष्ठ २) । कोही संघर्ष गरिरहेको छ वा सहयोग माग्छ भने जुनसुकै बेला समयमै सहयोगको प्रस्ताव गर्नुहोस्: कसैले एक महिना पर्खनुपर्दैन ।

यी कुरालाई छुट्टै राख्नुहोस्

- **अनुभव** आघातपूर्ण हुन सक्छ: यसले के भयो भन्ने बताउँछ ।
- **निदानले** लामो समयसम्म रहने प्रतिक्रियाको ढाँचा बताउँछ, जसको मूल्याङ्कन तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्छन् ।
- आघातपूर्ण अनुभव भोग्दैमा कसैलाई रोग लागेको हुँदैन । सामान्य प्रतिक्रिया हुनुको अर्थ अनुभव गम्भीर थिएन भन्ने होइन ।

सन्दर्भका लागि मात्र

क्लिनिकल पुस्तिकाहरूले घटनापछिको पहिलो महिनाभित्र **acute stress disorder** (तीव्र तनाव विकार; DSM-5-TR: ३ दिनदेखि १ महिना) को वर्णन गर्छन्, र महत्त्वपूर्ण लक्षणहरू एक महिनाभन्दा बढी रहेमा **post-traumatic stress disorder** (आघातपछिको तनाव विकार) बारे विचार गर्छन् । ICD-11 ले **acute stress reaction** (तीव्र तनाव प्रतिक्रिया) लाई सामान्यतया केही दिनभित्र कम हुन थाल्ने सामान्य प्रतिक्रिया मान्छ । यी शब्द सहभागीहरूसँग प्रयोग नगर्नुहोस्, र निदान नगर्नुहोस् ।

कसैले *"ट्रमा"* भनेमा · उदाहरण: अभ्यास कार्डहरू, पृष्ठ ४

शब्द नसच्याउनुहोस् र ट्रमाबारे छलफल सुरु नगर्नुहोस् । उहाँको अर्थ के हो भनेर सोध्नुहोस्: *"तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा के भन्न खोज्नुभएको हो? आफूमा के देख्नुहुन्छ?"* मानिसहरूले प्रायः यो शब्द कुनै खास डर वा परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्छन्, जस्तै *"फेरि बाढी आउला भनेर घर फर्कन डर लाग्छ"* वा *"भूकम्प आउला भनेर"* । यस्तो डर डरलाग्दो वा आघात पुऱ्याउन सक्ने अनुभवपछिको सामान्य प्रतिक्रिया हो । व्यक्तिले बताएको कुरामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र यो लामो समय रहिरहे, झन् बढे वा दैनिक जीवन कठिन बनाए समयमै सहयोगको बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।



स्रोतहरू: WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); WHO, Doing What Matters in Times of Stress (2020); WHO, mhGAP module: Assessment and management of conditions specifically related to stress (2013); WHO, ICD-11, QE84 Acute stress reaction; American Psychiatric Association, DSM-5-TR (2022) ।

अभ्यास कार्डहरू

मानिसहरूले के भन्न सक्छन् र तपाईं चरणबद्ध रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरणहरू । यी कुराकानी समूहका अगाडि होइन, निजी रूपमा हुन्छन् । शब्दहरू उदाहरण मात्र हुन्: आफ्नै शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, व्यक्तिको इच्छाअनुसार अघि बढ्नुहोस्, र कुनै तत्काल संकेत देखिएमा तुरुन्तै पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

तपाईंले भन्ने वा सोध्ने शब्दहरू · व्यक्तिले भन्न सक्ने कुरा · तपाईंका लागि निर्देशन (सादा अक्षर)

कसैले "ट्रमा" भनेमा

> *"बाढीपछि मलाई ट्रमा भएको छ । अब म एक्लै शौचालय जान सक्दिनँ ।"*

एउटा शब्दबाट तपाईंले प्रतिक्रिया दिन सक्ने ठोस परिवर्तनसम्म (पृष्ठ ३, *"कसैले 'ट्रमा' भनेमा"*) ।

1 उहाँको अर्थ सोध्नुहोस्

सोध्नुहोस् *"तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा के भन्न खोज्नुभएको हो? आफूमा के देख्नुहुन्छ?"*

उहाँ भन्नुहुन्छ *"पहिले म एक्लै जान्थें । अहिले एक मिनेटको काम भए पनि परिवारको कोही न कोही ढोकाबाहिर पर्खिनैपर्छ ।"*

2 यसबारे कुरा गर्न चाहनुहुन्छ कि भनेर सोध्नुहोस्, र केले यस्तो हुन्छ भनेर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्

सोध्नुहोस् *"यसबारे अलिकति कुरा गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो बेला तपाईंको मनमा के आउँछ?"*

उहाँ भन्नुहुन्छ *"कहिलेकाहीँ बाहिर चिच्याएको वा मानिस दौडिएको आवाज सुन्छु । मलाई लाग्छ: पानी आउँदैछ कि? भूकम्प हो कि? भित्रबाट के भइरहेको छ देख्न सक्दिनँ ।"*

3 प्रतिक्रियालाई सामान्य भनेर बुझाउनुहोस्

भन्नुहोस् *"तपाईंले जे भोग्नुभयो, त्यसपछि वरिपरि के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । जीवन अझै अस्थिर हुँदा धेरै मानिसलाई यस्तै लाग्छ ।"*

4 अहिले नै सहयोग गरिरहेको कुराको सम्मान गर्नुहोस्

भन्नुहोस् *"कसैलाई बाहिर पर्खन लगाउनु सुरक्षित महसुस गर्ने समझदार तरिका हो । उहाँले त्यो आवाज केको हो भनेर बताउन सक्नुहुन्छ, जस्तै राहत सामग्री बाँडिँदै गरेको ।"*

5 व्यावहारिक सुरक्षा जाँच्नुहोस्

गर्नुहोस् बत्ती, चुकुल, भीड र शौचालय जाने बाटोबारे सोध्नुहोस्, विशेष गरी रातिको समयमा । हरेक डर तनाव प्रतिक्रिया मात्र होइन: असुरक्षित अवस्था भए आश्रयस्थलका व्यवस्थापकलाई जानकारी दिनुहोस्, र संरक्षणसम्बन्धी चिन्ता भए आफ्नो सुरक्षा (safeguarding) प्रक्रिया पालना गर्नुहोस् ।

6 व्यक्ति चाहनुहुन्छ भने मात्र साना कदमहरूको प्रस्ताव गर्नुहोस्

सोध्नुहोस् *"केही सानो कुरा प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ? जस्तै, पर्खने मानिस केही पाइला टाढा बस्ने, वा तपाईंले बोलाउन सक्ने कुनै शब्द?"*

गर्नुहोस् व्यक्ति आफैं छान्नुहुन्छ । अहिलेको व्यवस्थाले काम गरिरहेको छ भने केही बदल्नुपर्दैन ।

7 सहयोगको बाटो खुला राख्नुहोस्

भन्नुहोस् *"धेरै मानिसका लागि समय र साथसँगै यो कम हुँदै जान्छ । यदि कम भएन, वा झन् गाह्रो भयो भने, हामी सँगै थप सहयोग खोज्न सक्छौं ।"*

गर्नुहोस् यो लामो समय रहिरहे, झन् बढे वा दैनिक जीवन कठिन बनाए समयमै सहयोगको प्रस्ताव गर्नुहोस् । डर हट्छ भनेर, वा कहिले हट्छ भनेर वाचा नगर्नुहोस् ।

अभ्यास कार्डहरू (क्रमशः)

तपाईंले भन्ने वा सोध्ने शब्दहरू व्यक्तिले भन्न सक्ने कुरा तपाईंका लागि निर्देशन (सादा अक्षर)

कसैले आफूलाई अरूसँग तुलना गरेमा

> *"अरू सबै ठीक देखिन्छन् । मैले त अहिलेसम्म यो पार गरिसक्नुपर्थ्यो ।"*

पोस्टर र पर्चा: मानिसहरूको प्रतिक्रिया फरक-फरक हुन्छ; महसुस गर्ने कुनै सही वा गलत तरिका हुँदैन ।

1 पहिले सुन्नुहोस्

सोध्नुहोस्: *"अहिलेसम्म यो पार गरिसक्नुपर्थ्यो भन्ने तपाईंलाई केले लगाउँछ?"*

2 प्रतिक्रियाहरू फरक-फरक हुन्छन् भनेर बताउनुहोस्

भन्नुहोस्: *"मानिसहरूको प्रतिक्रिया फरक-फरक तरिका र गतिमा हुन्छ । महसुस गर्ने कुनै सही वा गलत तरिका हुँदैन ।"*

3 अहिले नै सहयोग गरिरहेको कुरा खोज्नुहोस्

सोध्नुहोस्: *"गाहो दिनमा तपाईंलाई केले, अलिकति भए पनि, सहयोग गरेको छ?"*

गर्नुहोस्: पोस्टर वा पर्चाका साना कुराहरूलाई संकेतका रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् । तिनलाई परीक्षाका रूपमा होइन, विकल्पका रूपमा दिनुहोस् ।

4 सहयोगको बाटो खुला राख्नुहोस्

भन्नुहोस्: *"धेरै नराम्रो नहोउन्जेल पर्खनुपर्दैन । यसले दैनिक जीवन कठिन बनाइरहेको छ भने हामी सँगै सहयोग खोज्न सक्छौं ।"*

सम्झनाहरू बारम्बार फर्किरहँदा

> *"जे भयो, त्यो बारम्बार सम्झना आइरहन्छ, र म ध्यान दिन सक्दिनँ ।"*

पर्चा: *"बारम्बार फर्किने दुःखद सम्झना, वा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो"* ।

1 घटनाबारे होइन, अहिलेबारे सोध्नुहोस्

सोध्नुहोस्: *"यो कहिले फर्केर आउँछ? आउँदा तपाईं के महसुस गर्नुहुन्छ?"*

गर्नुहोस्: के भयो भन्ने विवरण नसोध्नुहोस् ।

2 यसलाई सामान्य भनेर बुझाउनुहोस्

भन्नुहोस्: *"डरलाग्दो अनुभवपछि दुःखद सम्झनाहरू फर्किरहनु सामान्य प्रतिक्रिया हो ।"*

3 उहाँ चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा प्रयास गर्न दिनुहोस्

गर्नुहोस्: पर्चामा जस्तै, बिस्तारै सास फेर्ने र देख्न र सुन्न सकिने तीनवटा कुरामा ध्यान दिने अभ्यासको प्रस्ताव गर्नुहोस् । यसले झन् नराम्रो महसुस गराएमा रोक्नुहोस् ।

4 कहिले थप हेर्ने भनेर जान्नुहोस्

गर्नुहोस्: घटनाको करिब एक महिनापछि पनि कुनै सुधार नभएमा, वा झन् बढ्दै गएमा वा दैनिक जीवन कठिन बनाएमा, त्यो व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् (पृष्ठ ३) । उहाँले माग्नुभयो भने अझ चाँडै ।